АНАТОМИЯ · ЛЕКЦИЯ 10 · 28 ОКТЯБРЯ · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Лобная и теменная кости

Кости свода черепа: лобная и теменная, швы и роднички; переломы свода и клиническая картина

👤 Запевалов Илья Андреевич

1. Задание преподавателя
2. Лобная кость
3. Теменная кость, швы и роднички
4. Переломы свода черепа и клиническая картина

Суть — главное одной фразой | Простыми словами | Важно | Таблицы

1 Задание преподавателя

ВАЖНО

Задание (28 октября): Видео и фото без текста — разобрать лобную и теменную кости.

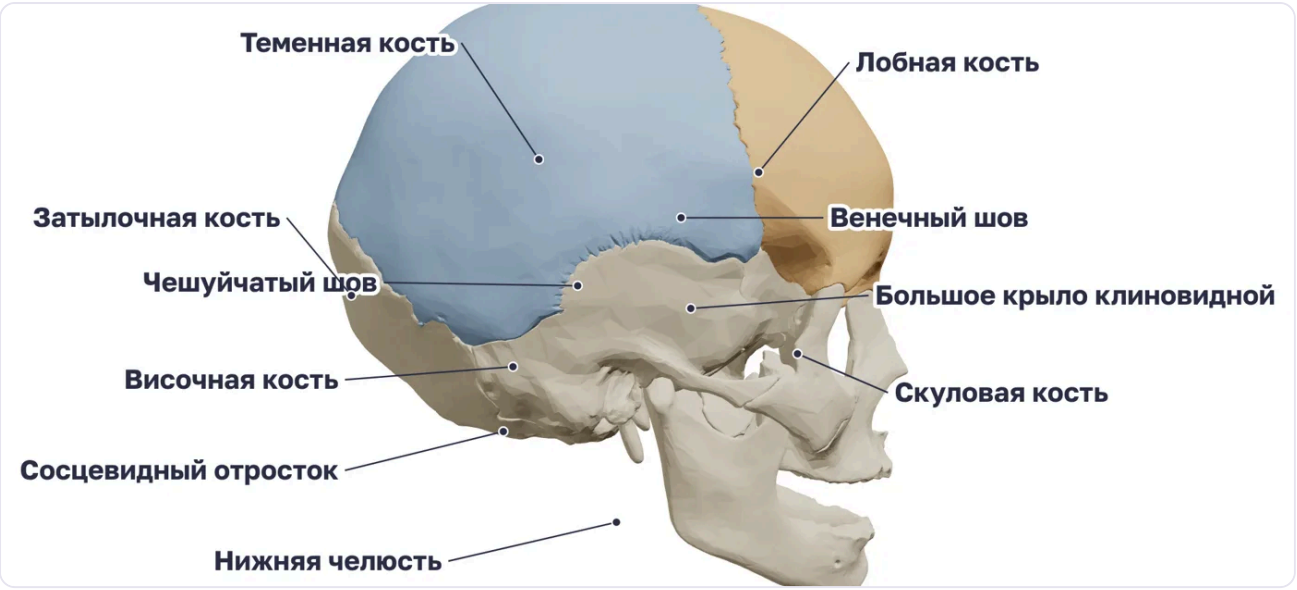
Анатомия лобной кости
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

Строение теменной кости
🎬 видео от преподавателя · ВКонтакте

2 Лобная кость

СУТЬ

Непарная кость мозгового отдела; образует лоб, переднюю часть свода и верхние стенки глазниц. Воздухоносная — внутри **лобная пазуха**.



Череп справа: лобная кость — жёлтая, теменная — голубая. Рисунок: BodyParts3D, © The Database Center for Life Science, CC BY-SA 2.1 JP; подписи — «Зубрёжка».

Часть	Что на ней
Лобная чешуя	лобные бугры, надбровные дуги, **надглазничный край** с надглазничной вырезкой (отверстием) — выходят надглазничные нерв и сосуды; **скуловой отросток**; изнутри — борозда верхнего сагиттального синуса, лобный гребень
Глазничные части (парные)	верхние стенки глазниц, ямка слёзной железы
Носовая часть	носовая ость; соединяется с носовыми костями
Лобная пазуха	открывается в средний носовой ход; при воспалении — фронтит

3 Теменная кость, швы и роднички

СУТЬ
Парная плоская четырёхугольная кость: 4 края и 4 угла; образует верх и бока свода черепа.

- Края: **лобный**, **затылочный**, **сагиттальный** (с другой теменной), **чешуйчатый** (с височной).
- Углы: лобный, затылочный, клиновидный, сосцевидный.
- Снаружи — **теменной бугор**, височные линии; изнутри — борозды средней менингеальной артерии (её разрыв → эпидуральная гематома) и сагиттального синуса.

Шов	Какие кости соединяет
Венечный	лобная + теменные
Сагиттальный	две теменные
Ламбдовидный	теменные + затылочная
Чешуйчатый	теменная + височная

Роднички новорождённого: **передний (большой)** — между лобной и теменными, закрывается к 12–18 месяцам; **задний (малый)** — между теменными и затылочной, к 2–3 месяцам; клиновидные и сосцевидные — к рождению или вскоре после. Большой родничок выбухает при повышении внутричерепного давления, западает при обезвоживании.

4 Переломы свода черепа и клиническая картина

СУТЬ

Переломы свода бывают линейные (трещины) и вдавленные; опасны не столько сами по себе, сколько повреждением мозга и сосудов.

Повреждение	Клиническая картина
Линейный перелом	местная боль, гематома мягких тканей; часто сопровождается сотрясением или ушибом мозга
Вдавленный перелом	западение (ступенька) на своде, очаговые симптомы (парезы, нарушения речи) — отломок давит на мозг
Эпидуральная гематома (височно-теменная область, разрыв средней менингеальной артерии)	**«светлый промежуток»**: потеря сознания → улучшение → снова ухудшение; расширение зрачка на стороне гематомы, паралич с противоположной стороны
Перелом лобной кости с пазухой	деформация лба, подкожная эмфизема, носовое кровотечение, ликворея из носа (перелом задней стенки пазухи)

Признаки ЧМТ: потеря сознания, головная боль, тошнота и рвота, амнезия; при ушибе — очаговая неврологическая симптоматика. Сотрясение — без органических изменений, симптомы проходят.

ВАЖНО

Первая помощь: уложить на спину (без сознания — на бок, чтобы не захлебнулся рвотой), холод на голову, асептическая повязка на рану; при вдавленном переломе — повязка-«бублик» без давления на отломки. Контроль сознания, дыхания, пульса, зрачков; транспорт лёжа, срочно в стационар.

📌 Что запомнить

- Лобная: чешуя, глазничные части, носовая часть, лобная пазуха.
- Теменная: 4 края (лобный, затылочный, сагиттальный, чешуйчатый) и 4 угла.
- Швы: венечный, сагиттальный, ламбдовидный, чешуйчатый.
- Большой родничок — к 12–18 мес, малый — к 2–3 мес.
- Эпидуральная гематома — «светлый промежуток».

🃏 Вопросы для самопроверки

Части лобной кости
Лобная чешуя, две глазничные части, носовая часть

Где лобная пазуха и куда открывается?
В лобной кости за надбровными дугами; в средний носовой ход

Что выходит через надглазничную вырезку?
Надглазничные нерв и сосуды

Края теменной кости
Лобный, затылочный, сагиттальный, чешуйчатый

Венечный шов
Между лобной и теменными костями

Ламбдовидный шов
Между теменными и затылочной

Когда закрывается большой родничок?
К 12–18 месяцам

Когда закрывается малый родничок?
К 2–3 месяцам

Эпидуральная гематома — чья артерия?
Средняя менингеальная (борозда на внутренней поверхности теменной)

«Светлый промежуток»
Временное улучшение после потери сознания — признак эпидуральной гематомы

✅ Тест с ответами

1. Воздухоносная кость свода черепа:
Ответ: Лобная — В лобной кости — лобная пазуха.

2. Сагиттальный шов соединяет:
Ответ: Две теменные — Проходит по средней линии свода.

3. Большой родничок закрывается к:
Ответ: 12–18 месяцам — Малый — к 2–3 месяцам.

4. «Светлый промежуток» характерен для:
Ответ: Эпидуральной гематомы — Гематома нарастает постепенно.

5. При вдавленном переломе свода накладывают:
Ответ: Повязку-«бублик» без давления — Нельзя давить на отломки.

Конспект составлен по лекции и дополнительным материалам преподавателя. Иллюстрации: схемы — собственные; иконки Healthicons (MIT); рисунки Servier Medical Art (CC BY 3.0), DBCLS (CC BY 4.0) и OpenClipart (CC0) из коллекции Bioicons; слайды — материалы к занятиям.